

重视药物相互作用, 保证用药安全

柯元南

(中日友好医院 心内科, 北京 100029)

药物治疗是各种疾病治疗的主要方法之一, 现代医学的进步研发出数以千计的药物, 使人类的各种疾病得到治疗。在临床上, 一个人可以同时患多种疾病, 因此可能同时用 2 种或 2 种以上的药物治疗。不同药物在人体内可能发生相互作用, 产生意想不到的结果。缺少临床经验的医师在制定治疗方案时, 往往只是根据患者有几种疾病, 开出各种药物, 有时一个患者可能同时使用几十种药物, 而对于这些药物在体内会发生什么相互作用? 疗效增加还是减弱? 是否会发生严重不良反应? 知之甚少、或完全不知, 这就有潜在的风险。因此, 深入了解各种药物在体内吸收、代谢、排泄过程, 以及各种药物在体内的相互作用, 对于保证用药安全是非常重要的。

所谓‘药物相互作用’是指某一种药物的作用由于其它药物或化学物质的存在而受到干扰, 使该药的疗效发生变化, 或产生药物不良反应。药物相互作用主要是指药物与药物之间的相互作用, 同时也包括药物与烟、酒、食物之间的相互作用。药物在人体内由于相互作用引起药代动力学和药效学的改变, 从而使药效增强、毒性增大, 或使药效降低、毒性减弱。例如: 食物、可吸附药物的活性炭、增加肠蠕动的药物等可减少或延缓药物的吸收。又如: 两种或多种药物可以在体内竞争蛋白结合部位、改变游离型药物的比例, 而只有游离型药物才有生物活性, 所以游离型药物比例的改变, 会影响到各种药物的疗效。如果游离型药物增加, 该药的作用增强, 毒性会增大。一种最常见的药物相互作用的方式是肝酶抑制作用。药物进入体内后, 一般都要经过肝酶系统代谢为无毒性的化合物后, 经肾脏排泄的。有许多药物是经过肝脏的一种叫做细胞色素 P450 3A4 的同功酶代谢的。两种都是经过这一酶代谢的药物同时使用, 肝脏可能会来不及代谢, 结果这两种药物的血药浓度均升高, 甚至发生严重不良反应。有些药物如利福平、苯妥因等则可能增强肝脏药物代



柯元南: 1970 年毕业于协和医科大学医学系, 1982 年毕业于德国海德堡大学医学院, 获医学博士学位。1992 年晋升为主任医师, 教授。现任卫生部中日友好医院全国中西医结合心血管病中心副主任、心内科主任、大内科主任、博士生导师、中华心血管病学会委员、中华心血管病杂志编委、北京心血管病学会委员。擅长心血管病临床、心血管临床药理研究及新药开发。发表论文 100 余篇, 参与专著撰写 8 部。1987 年获全国中青年优秀医学论文二等奖, 1988 年获卫生部鼓励科研基金二等奖, 1994 年获国务院特殊津贴。

谢酶的活性, 使肝脏代谢药物增加, 因而会降低药效, 这种药物相互作用叫做肝酶诱导作用。如果事先注意到这一问题, 就可以避免严重不良反应的发生。

食物影响药物疗效的例子也很多。例如, 服药同时饮酒可能会增加药物吸收; 葡萄柚(西柚)通过肝酶抑制作用, 可以使许多药物的血药浓度升高, 毒副作用增强。所以服药的患者最好不要饮酒和食用葡萄柚。临床上药物相互作用的例子不胜枚举, 例如: 有一女性甲状腺功能减低的患者常年服用优甲乐(左旋甲状腺素), 后来因为心房颤动, 为了预防脑栓塞又加用了华法令。由于这两种药

物体内的相互作用,在常规剂量(优甲乐 50 μ g/d,华法令 3mg/d)下发生心悸、出汗等优甲乐过量现象,血凝监测 INR(国际标准化比率)也明显超标,提示华法令也过量。经调整剂量(优甲乐 25 μ g/d,华法令 0.75mg/d),患者症状消失,血凝监测 INR 也符合要求。又如一名男性心力衰竭的患者,因为同时有心房颤动,服用华法令 1mg/d 和氯沙坦 50mg/d,血凝指标 INR 2.0。将氯沙坦增加剂量至 150mg/d,肾功能有所恶化,血肌酐从 1.7 mg/dl 升至 2.5mg/dl。在华法令剂量不变(1mg/d)的情况下,INR 升至 6.0,同时临床上出现黑便。这一病例黑便的原因可能是由于氯沙坦增量引起肾功能不全加重,华法令排泄减少引起血药浓度增加、药效增加所致。

如何减少药物相互作用,减少因相互作用引起的严重不良反应,确保临床用药安全?首先,作为一名临床医生,应当详细了解所开处方每种药

物的药理学特性(吸收、分布、代谢、排泄及常见的药物相互作用等)。在处方中容易出现相互作用的一些药物,如:地戈辛、他丁类调脂药、华法令、西咪替丁类制酸药、胺碘酮、红霉素、环孢素等,要予以特别的关注,特别小心,必要时可查阅药学专著。第二,医生在制定治疗方案时,应根据病情综合考虑,抓主要矛盾,尽量减少用药种类。第三,对于老年人、肝肾功能减退的患者,要特别注意用药安全。因为在这种情况下,药物在体内的代谢和排泄减少,会引起血药浓度升高而易发生毒副作用。第四,临床医生在日常诊疗工作中要注意积累用药方面的临床经验。第五,即使是很有经验的临床医生,也要仔细观察病情变化,患者对于治疗的反应,并作必要的监测。只有这样,才能尽量避免药物相互作用引起的严重不良反应,保证临床用药安全。

通讯

全国中西医结合心血管病中心成立

卫生部中日友好医院于2005年8月9日正式成立全国中西医结合心血管病中心,并于10月11日(中国敬老日、重阳节)举行成立揭牌仪式。中心由我国著名的中西医结合医学家、中国科学院陈可冀院士出任中心主任,中心副主任分别由卫生部中日友好医院大内科主任、心内科主任、心脏内科专家柯元南教授,中医大内科主任、中西医结合心脏疾病专家史载祥教授,心脏血管外科主任、心脏外科专家王凤林教授担任。

在现代临床疑难病的防治方面,中西医结合、优势互补越来越显示出不可替代的作用。但迄今为止,国内尚无心血管病的中西医结合诊疗中心,在一定程度上影响了中西医结合事业的发展。中日友好医院是国内一流的卫生部直属的综合医院,硬件设施先进,西医、中医技术力量雄厚。从建院之日起,中西医优势互补是医院的一个重要特色。因此,以国内外著名的中西医结合心血管病专家为主导,集合一批中青年骨干力量,在中日友好医院西医、中医心血管病科和相关基础研究科室的基础上筹建中西医结合心血管病中心,对促进中西医结合心血管病防治研究和医院的特色建设,具有重要的意义。

中心由5个病区、冠心病监护病房、导管室、心血管病实验室和相关检查科室组成,床位150余张。有院士1名,高级职称医师30余名,其中有博士学位15名,硕士学位16名。中心的发展目标是:集临床、科研、教学、新药开发为一体,以临床为核心,科研为导向,在现代医学先进诊疗条件基础上,突出中西医结合特色,使中西医结合心血管病防治研究处于国内领先地位,某些领域心血管病防治达到国际先进水平。

中心实施一系列新的方法和举措,为病人提供最佳诊疗,探索最佳的中西医结合模式,如病房的中西医、内外科联合查房;成立由中、西医组成的专病研究小组;中西医病房之间的会诊、转诊制度;院士主持疑难疾病的多学科联合会诊;挂号实行中心一票制等等。中心成立后,将秉承“同心协力,继承创新,优势互补,优质服务”的理念,以病人为本,实施规范化、个体化治疗。中心的医疗特色主要为:1、设有急性心肌梗死治疗的“绿色通道”,治疗水平已进入国际先进行列;2、冠心病的药物、介入和外科规范化治疗,疗效达国内先进水平;3、中西医结合治疗难治性高血压、心力衰竭及相关疾病,已形成了完整的、规范化的最佳治疗方案;4、中西医结合预防冠心病介入治疗后再狭窄、微循环障碍达国内领先水平;5、大隐静脉曲张的微创治疗达国际先进水平;6、围手术期的中西医结合康复治疗。